

Eumicetoma: el pie de Madura

Historia del PDF recibido · varón de 38 años

SECUENCIA CLÍNICA

Trabajador rural de zona tropical. Refiere punción con una espina mientras trabajaba descalzo.

El nódulo indoloro progresa durante tres años. Luego aparecen tumefacción, fístulas y granos oscuros.

CLAVE DIAGNÓSTICA

Tumefacción + fístulas + granos

La tríada clásica del micetoma. La ausencia de fiebre no descarta una infección crónica localizada.



INTERPRETACIÓN

Granos negros

Orientan a eumicetoma por hongos dematiáceos. *Madurella mycetomatis* es una causa importante; la especie se confirma con estudio micológico.

LABORATORIO

Confirmación

Examen directo de los granos, histopatología con PAS/Grocott y cultivo. PCR puede ayudar según disponibilidad.

IMAGEN

Extensión

Ecografía, radiografía o resonancia permiten valorar tejidos profundos y compromiso óseo antes del tratamiento.

Esporotricosis linfocutánea

Historia del PDF recibido · mujer de 36 años

DÍA 0

Inoculación

Trabajadora rural. Tras injertar naranjos, presenta una lesión en un dedo; la puerta de entrada puede ser una espina, astilla o materia vegetal.

EVOLUCIÓN LOCAL

Lesión primaria

La pápula o el nódulo inicial aumenta de tamaño y puede ulcerarse, sin necesidad de síntomas sistémicos.

PISTA DECISIVA

Patrón esporotricoide

Aparecen nuevos nódulos ascendentes siguiendo el drenaje linfático regional. Este patrón no equivale por sí mismo a diseminación hematógena.

DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIAL

SPOROTHRIX SPP.

Esporotricosis

Nódulos en cadena por los vasos linfáticos. El cultivo del espécimen clínico es la prueba de referencia.

DIFERENCIAL

Cromoblastomicosis

Placa verrugosa crónica; los cuerpos muriformes o escleróticos orientan el diagnóstico.

DIFERENCIAL

Micetoma

Masa o tumefacción, trayectos fistulosos y granos. Puede alcanzar músculo y hueso.

PRINCIPIO SEGURO

Tratamiento orientado por forma clínica

Las formas cutáneas suelen tratarse con itraconazol. Las formas graves o diseminadas requieren otra evaluación y no deben confundirse con el patrón linfocutáneo regional.

Eumicetoma: segundo paciente

Fotografías separadas · varón de 62 años

NO MEZCLAR CON EL CASO DE 38 AÑOS

Historia independiente

Trabajador rural. Herida con clavo en el pie derecho unos 20 años antes; ocho meses después comenzó el aumento de volumen metatarsiano.



HALLAZGOS CLÍNICOS



EVOLUCIÓN DOCUMENTADA

CRONOLOGÍA

Curso de décadas

Recurrencias, cirugías, aumento progresivo de volumen, limitación funcional y lesiones ulceradas con signos de infección.

CONCLUSIÓN

Diagnóstico sindrómico

La cronicidad, la deformidad y las fístulas orientan a eumicetoma; la confirmación requiere granos, biopsia y cultivo.

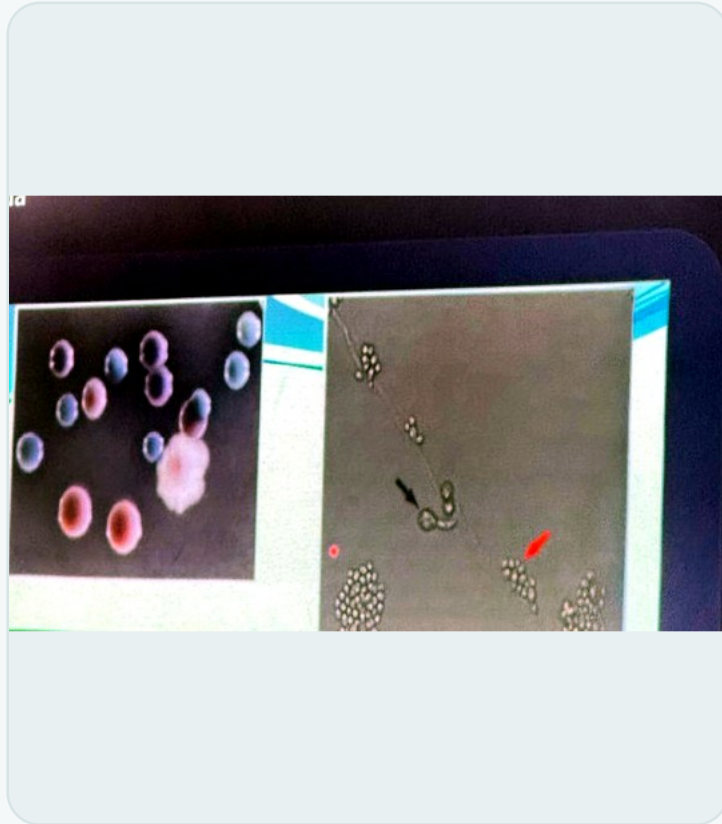
CONTROL DE FIDELIDAD

Dos historias, una misma entidad clínica

Las edades, el mecanismo del trauma y la duración se conservan por separado. Las fotografías no sustituyen el estudio microbiológico.

Candida: del comensal a la infección

Riesgo, muestra e interpretación



RESERVORIOS HABITUALES

Candida puede colonizar tubo digestivo, mucosa genital, piel y región periungueal. Un aislamiento se interpreta según la clínica y el sitio de la muestra.

CONTEXTO

Factores predisponentes

Antibióticos de amplio espectro, catéteres, cirugía, neutropenia, cáncer, trasplante, prematuridad o inmunosupresión.

EPIDEMIOLOGÍA

Origen

Muchas infecciones son endógenas; también hay transmisión asociada a la atención sanitaria.

CÓMO ESTUDIAR LA SOSPECHA

01

Muestra

Depende del foco: raspado, exudado, sangre u otra muestra estéril. La técnica debe corresponder al síndrome.

02

Microscopía

Levaduras gemantes y pseudohifas pueden orientar, pero el significado cambia según el sitio clínico.

03

Cultivo

Permite aislar e identificar la especie; en infección invasiva puede requerirse sensibilidad antifúngica.

EVITA EL SOBREDIAGNÓSTICO

Colonización no es igual a candidiasis invasiva

Un cultivo positivo de un sitio no estéril no demuestra por sí solo enfermedad sistémica. La interpretación integra síntomas, exploración, factores de riesgo y tipo de muestra.

Candidiasis mucosa, cutánea y ungueal

Imágenes de la clase · orientación, no diagnóstico aislado



PSEUDOMEMBRANOSA

Mucosa oral

Placas blancas de aspecto cremoso pueden desprenderse y dejar base eritematosa. La forma hiperplásica crónica puede no desprenderse al raspado.



CUTÁNEA / PERIUNGUEAL

Piel y uñas

Intertrigo en zonas húmedas, eritema con lesiones satélite, paroniquia y alteración ungueal. Deben considerarse diagnósticos alternativos.

PRINCIPIO TERAPÉUTICO

El tratamiento depende del foco y del paciente

La terapia se selecciona según localización, extensión, especie, gravedad y factores del huésped. No se indican antibióticos ni corticoides de rutina por el aspecto de una lesión fúngica.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

OMS: fichas de micetoma y cromoblastomycosis. CDC: clinical overview de esporotricosis y candidiasis. Contenido reconstruido a partir de la clase y corregido para evitar afirmaciones absolutas.